Anamnesefragen

Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?

Schmerzen – Anamnese

Wo genau haben Sie diese Schmerzen?
Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? z.B. ins Bein, bis zu Fuß(bunu sormak özellikle önemliymiş?
Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, z. B. Fehlbewegungen, Hebetrauma oder Kälteexposition? Haben Sie sich an Rucken verletzt?
Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder kommen und gehen sie?
Ist es das erste Mal, oder hatten Sie früher schon ähnliche Symptome?
Waren Sie deswegen schon einmal bei Ihrem Hausarzt?
Wurden bei Ihnen Untersuchungen durchgeführt?
Sind die Schmerzen im Verlauf schlimmer geworden?
Können Sie die Schmerzen genauer beschreiben? Sind sie stechend oder dumpf?
Wie stark sind die Schmerzen?
Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, z. B. Bewegung, oder etwas, das sie lindert, z. B. Hinlegen?
Haben Sie etwas gegen die Schmerzen eingenommen?
Wie viel mg Diclofenac haben Sie eingenommen?
Wer hat Ihnen das verschrieben?

Haben Sie Schmerzen beim Gehen oder Krämpfe in den Beinen, die nach einer Pause wieder besser werden?
Ab welcher Gehstrecke beginnen die Schmerzen?
Verschwinden die Schmerzen in Ruhe wieder? Nach wie vielen Minuten?
Müssen Sie beim Gehen regelmäßig stehen bleiben?
Haben Sie auch Schmerzen in Ruhe, vor allem nachts?
Werden die Schmerzen besser, wenn Sie das Bein herunterhängen lassen?
Müssen Sie nachts aufstehen, weil die Beine schmerzen?
Haben Sie schlecht heilende Wunden an den Füßen oder Zehen?
Gibt es Verfärbungen der Haut (blass, blau, dunkel)?
Haben Sie Haarausfall an den Unterschenkeln bemerkt?
Sind die Füße oft kalt?

Neurologische Symptome

Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Lähmungserscheinungen oder Kraftverlust haben?
Haben Sie Kribbelgefühle oder Taubheitsgefühle bemerkt?

Haben Sie unvillkürlich Urin oder Stul verloren?-unutma

Medikamente / Osteoporose

Darf ich fragen, warum Sie Calcium einnehmen? Leiden Sie an Knochenschwund?
Wer hat Ihnen das verschrieben?

Sozialanamnese / Belastung

Außer Ihren zwei Kindern – haben Sie noch weitere Kinder?
Tragen Sie häufig schwere Sachen?
Trotz Ihrer Pollenallergie: Können Sie als Floristin problemlos arbeiten, oder haben Sie dabei Beschwerden?
Treiben Sie Sport?

Ich habe einen Verdacht auf eine Muskelverspannung aufgrund des Hebens eines schweren Kübels. Aber das bleibt nur eine Vermutung, wir sollen weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann ein wenig Blut abnehmen und dann eine Röntgenaufnahme Ihrer Lenden und auch eine MRT durchführen.

MRT:
Beim Lenden-MRT wird ein starkes Magnetfeld verwendet, um detaillierte Bilder Ihrer unteren Rückenmuskulatur und -struktur zu erstellen. Es ist schmerzfrei, aber Sie müssen während des Scans still liegen.

Röntgen:Beim Lenden-Röntgen werden Röntgenstrahlen verwendet, um Bilder Ihrer unteren Wirbelsäule zu erstellen. Es ist eine schnelle und schmerzfreie Untersuchung, bei der Sie sich für kurze Zeit in bestimmten Positionen halten müssen

Ich habe einen Verdacht auf **Bandscheibenvorfall**. Das ist eine Verlagerung (yer değiştirme)der Bandscheibe, die eine Druck der Nervenwurzeln kommen kann.

Vorstellung:

ä

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen.
Bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von **2,6 mmol/L** hat. Dieser Wert ist **deutlich erniedrigt** und entspricht einer **Hypokaliämie**.

Es geht um Frau Astrid Fischelmann. Sie ist 55 Jahre alt, geboren am 11.04.1968. Sie ist 1,64 m groß und wiegt 64,3 kg.
Frau Fischelmann stellt sich bei uns wegen seit gestern bestehender Schmerzen im unteren Lendenbereich vor.
Laut Aussage der Patientin sind die Schmerzen plötzlich nach einer Hebung eines schweren Kübels aufgetreten.
Sie berichtet, dass die Schmerzen ins linke Bein bis zum Fuß ausstrahlen.
Die Schmerzintensität liegt bei 7/10 auf der Schmerzskala.
Nach Angabe der Patientin sind die Schmerzen stechend, brennend, ziehend, persistierend und progredient.
Die Schmerzen verschlimmern sich beim Aufstehen, Sitzen und nach vorne Beugen, während sie sich beim Liegen, bei Beinhochlagerung und nach der Einnahme von Diclofenac 75 mg bessern. Nach der Einnahme von Diclofenac klagt sie über Übelkeit.
Außerdem hat sie ähnliche Beschwerden seit einem Jahr, jedoch waren sie früher leichter.
Die Fragen zu Parese, Parästhesie und Urin-Stuhlinkontinenz wurden verneint.
Vegetativ-anamnestisch ergab sich lediglich Hyperhidrose, Kaltschweiß und Menopause vor fünf Jahren.
Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte sie Migräne, Z. n. Sectio caesarea vor 30 Jahren und Z. n. Vakuumextraktion vor 28 Jahren.
Bei der Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von Ibuprofen 400 mg b. B., Dolortriptan b. B. und Calcium Sandoz b. B. gegen Osteoporose.
Die Allergieanamnese war unauffällig bis auf Heuschnupfen, der sich in Rhinokonjunktivitis äußert.
Bei der Noxenanamnese erwähnte sie lediglich eine Zigarette pro zwei bis drei Wochen und zwei Gläser Wein am Wochenende. Drogenkonsum wurde verneint.
Die Familienanamnese ergab arterielle Hypertonie beim Vater, Diabetes mellitus Typ II bei der Mutter und Lungenkarzinom bei der Schwester, daran gestorben.
Sozialanamnestisch ist sie Floristin von Beruf, geschieden, wohnt allein und hat zwei Söhne.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Muskelverspannungs-Lumbalgie / lumbaler Diskusprolapsus (aussthrahlung olduğu için bu tanu, olmasa lumbalgie sadece)hin.
Lumbalgie mit Ausstrahlung ins linke Bein, das Auftreten nach einer Hebung eines schweren Kübels, ohne Parese, ohne Parästhesie, ohne Urin-Stuhlinkontinenz sprechen dafür.

Differentialdiagnostisch kommen lumbaler Diskusprolaps, Muskelverspannung, Spinalkanalstenose, Lendenwirbelfraktur, Knochenmetastasen , Osteochondrose und Urolithiasis in Betracht.

Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung vornehmen, das Lasègue-Zeichen überprüfen, die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen.
Im Labor würde ich ein kleines Blutbild, Entzündungsparameter (CRP, BSG, ggf. PCT), Vitamin-D3-Profil, Elektrolyte, Nieren- und Leberwerte und einen Urinstatus bestimmen lassen.
Anschließend werde ich eine Röntgenaufnahme des Lendenbereichs in zwei Ebenen und ggf. ein MRT, ggf. eine farbkodierte Dopplersonografie der Beingefäße und ggf. ein CT der LWS durchführen und ein Konsil bei der Abteilung für Orthopädie anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapie:
Die Patientin wird ambulant behandelt.
Die Patientin sollte eine symptomatische Behandlung wie Analgetika, Muskelrelaxantien (Methocarbamol) und ggf. eine Einspritzung von Kortison erhalten.
Physiotherapie wird empfohlen.
Eine operative Therapie, wie z. B. eine Nukleoplastie, wird vorgeschlagen, wenn ein schwerer Bandscheibenvorfall vorliegt oder Red-Flag-Symptome auftreten, wie z. B. Reithosenanästhesie, Harn- und Stuhlinkontinenz, Paresen, Zustand nach Wirbelfraktur, bekannte Osteoporose oder Infektionen.

Reaktionen:

Darf ich nach der Einnahme von Medikamenten nach Hause? Soll ich hierbleiben? Pyelonephritis - Diskusprolaps

- Ja, Sie sollen bei uns bleiben, bis die Ergebnisse vorliegen. Dann können wir entscheiden.
- Kann jemand anderes Ihre Sachen mitbringen?
- Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.
- Es ist nicht gefährlich, keine Sorge, aber es wäre besser, wenn Sie hier bei uns bleiben, damit wir schnell reagieren können, wenn sich bei Ihnen etwas Neues entwickelt.

Wissen Sie, wo Fersen sind? Könnten Beim Zusammenfassen: sagen Sie mir lieber, was Sie machen? Sie bitte es nachsehen? Ist es etwas Schlimmes? Soll es operiert werden? Reizmagen - Diskusprolaps

- Nach unserem Gespräch untersuche ich Sie gerne körperlich.
- Ich werde mein Bestes versuchen, Ihnen zu helfen, auch bei Ihren Fersenschmerzen, aber **Sie sollten auch einen Termin bei einem Orthopäden vereinbaren.**

Das Lasègue-Zeichen ist ein klinischer neurologischer Test, der verwendet wird, um eine Reizung des Nervus ischiadicus (Ischiasnerv) oder einen Bandscheibenvorfall im Lendenwirbelsäulenbereich festzustellen.

Durchführung (Untersuchung):

Der Patient liegt flach auf dem Rücken.

Der Untersucher hebt das gestreckte Bein des Patienten langsam an.

Positives Lasègue-Zeichen:

Das Zeichen gilt als positiv, wenn beim Anheben des gestreckten Beins (meist zwischen 30° und 70°)

starke Schmerzen auftreten, die: vom unteren Rücken über das Gesäß bis ins Bein ausstrahlen.

Diese Schmerzen deuten auf eine Nervenwurzelreizung hin, häufig durch: einen Bandscheibenvorfall

oder eine Ischialgie

Negatives Lasègue-Zeichen:

Treten keine ausstrahlenden Schmerzen auf, ist das Zeichen negativ und eine relevante Nervenreizung eher unwahrscheinlich.

Bei der körperlichen Untersuchung werde ich darauf achten, ob motorische oder sensible Störungen vorhanden sind, sowie auf die Reflexe, den Puls, Verfarbung der Haut und kalte Haut.“

Hexenschuss → Plötzliche starke Schmerzen in unteren Rücken.
(ein Hexe, den Menschen geschossen hat.)

Therapie:

- Bei fehlendem Kinderwunsch: Ovulationshemmern (Cyproteronacetat mit Ethinylestradiol)
- Bei Kinderwunsch: Clomifen, Gonadotropinen

19. Diskus-Prolaps s.11 (new)

Sport Arbeit Anamnese
SOF → Treiben Sie anstrengender Sport?

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

Patientin spricht nicht so deutlich, sie hatte monotone Stimme. Ich habe am Anfang gedacht, sie hätte Parkinson.

- Astrid Fischelmann
- 55J.
- *11.04.1968
- 64,3kg
- 1,64m
- ~~Ich möchte mit einem deutschen Arzt sprechen!~~ Ja das ist möglich. Allerdings sind die anderen Ärzte alle beschäftigt, deshalb sollen Sie noch einige Stunden warten bis sie Zeit für Sie haben. Aber ich kann mich jetzt gerne **gleich** um Sie kümmern.

✓ Ich verstehe Ihren Wunsch sehr gut. Im Moment bin ich für Ihre Behandlung zuständig und wir machen das gemeinsam, ich spreche sehr gut Deutsch und Sie können alles in Ruhe mit mir besprechen.

-Hauptbeschwerde

- Lumbalgie / Lumboischialgie (Lendenschmerzen / Hexenschuss)
  - Seit gestern
  - mittige untere Rückenschmerzen
  - Persistierend
  - stechend, brennend, ziehend
  - Ausstrahlung li. Bein: Bis zur Ferse?
  - Plötzlich begonnen
  - NRS: zunächst 7/10, nach Einnahme von Diclofenac 75mg: 4/10
  - Auslöser: Hebung eines Kübels im Garten (es ist eine sehr schwere Sache)
    - Haben Sie sich verletzt?
    - Gab es einen bestimmten Auslöser? (Fehlbewegungen, Hebetraumen, Kaltdurchlaufmedien, Sogwirkung beim Heben, Kälteexposition, Klimawechsel, Überlastungen)
  - Verstärkerende Faktoren: Aufstehen, Sitzen und **sich** nach vorne beugen. Haben Sie Schmerzen beim Gehen oder Krämpfe in den Beinen, die nach einer Pause wieder besser werden?
  - Lindernde Faktoren: Liegen sowie Beinhochlagerung
- Ähnliche Beschwerde seit 1J. aber leichter. Hatten Sie schon einen Unfall?
- Keine neurologischen Symptome (keine Parästhesie oder Hypästhesie).
  - Haben Sie Kribbeln, Taubheitsgefühl oder Lähmung? Muskelschwäche oder Kraftminderung? ✓
- Nausea nach der Einnahme von Diclofenac: Übelkeit

R → Ich verstehe, dass Diclofenac Ihnen geholfen hat. Aber bitte Nehmen Sie kein Medikament ohne ärztlicher Rat. Es kann NW verursachen. Wie viel mg haben Sie Diclofenac eingenommen? Wer hat das Ihnen verschrieben?

- Versuchen Sie, sich zu entspannen. Schließen Sie die Augen, atmen Sie ruhig und denken Sie an ein positives Bild. Zum Beispiel, dass Sie allein am Strand sind und dem Wellenrauschen zuhören (geführte Traumreisen / geführte Phantasiereisen/ Meditationsreisen). Entspannungsübungen

-vegetative Symptomatik

- Kaltschweißigkeit (seit langer Zeit)

-gyn

- Vor 5 Jahren Menopause, ✓
- Vakuumextraktion für den ersten Sohn, (Saugglockegeburt) ✓

- Sectio Caesarea für den zweiten Sohn (Kaiserschnitt)

-Vorerkrankungen

- Migräne: drückend, bds, rezidivierende, alle 3 Mo. mit Photopsie (Lichtempfindlichkeit) / Aura

-Vor-OPs

- Sectio Caesarea vor 30 J.: ich hatte einen Kaiserschnitt und eine ein Saugglocke Geburt
- Vakuumextraktion vor 28 J.

-Medikation

- Ibuprofen 400mg b.B.
- Dolortriptan gegen Migräne b.B.
- Calcium Sandoz b.B.
  - Warum nehmen Sie Calcium? Leiden Sie an Knochenschwund (= Osteoporosis)?

-Allergien

- allergische Rhinokonjunktivitis im Frühjahr (Heuschnupfen)

-Noxen

- Nikotinkonsum: eine Zig. alle 2/3 Wochen mit Alkohol
- Alkoholkonsum: 2Gl.Wein am WE
- Drogenkonsum wurde verneint: ~~Warum fragen Sie nach Drogen?~~
  - Bestimmte Drogen in Kombination mit bestimmten Medikamenten können zu schweren Nebenwirkungen führen. Weil Drogen Wechselwirkung mit anderen Medikamenten haben können.

-Sozialanamnese

- Floristin von Beruf (Blumenhändler) Tragen Sie offen schwere Sache?
- geschieden, alleinwohnend
- hat 2 gesunde Sohne
- Treiben Sie Sport?

Trotz Ihrer Polyallergie: Können Sie als Floristin problemlos arbeiten, oder haben Sie dabei Beschwerden?

Außer ihren zwei Kinder, Haben Sie noch weitere Kinder?

-Familienanamnese

- Mutter: 78J. DM2
- Vater: 80J., aHT
- Schwester: verstorben mit 52J. an Bronchial Ca. Lungenkrebs → "Zunächst einmal tut mir das sehr leid."
  - Meine Schwester hatte Krebs mit Metastase, habe ich Krebs auch? Ich habe Angst
    - Das ist möglich, aber ~~ich~~ denke nicht, wir werden weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ich erkläre Ihnen nun, welche.

Ich gehe nicht davon aus, weil Ihre Beschwerden nicht zu einem Krebs passen

- Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit! Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.

Ich habe einen Verdacht auf **Bandscheibenvorfall**. Das ist eine Verlagerung der Bandscheibe, die eine Druck der Nervenwurzeln kommen kann.

Aber das bleibt nur eine Vermutung, wir sollen weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann ein wenig Blut abnehmen. Und dann eine Röntgenaufnahme Ihrer Lenden und auch eine MRT und eine Urinuntersuchung.

MRT:

Beim Lenden-MRT wird ein starkes Magnetfeld verwendet, um detaillierte Bilder Ihrer unteren Rückenmuskulatur und -struktur zu erstellen. Es ist schmerzfrei, aber Sie müssen während des Scans still liegen. Sie müssen Ihren Schmuck und alle Metallgegenstände ablegen.

Röntgen:

Ihrer unteren Rückenmuskulatur

Beim Lenden-Röntgen werden Röntgenstrahlen verwendet, um Bilder Ihrer unteren Wirbelsäule zu erstellen. Es ist eine schnelle und schmerzfreie Untersuchung, bei der Sie sich für kurze Zeit in bestimmten Positionen halten müssen (3)

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um **Frau Astrid Fischelmann, 55** Jahre alt, die in leicht reduziertem AZ (Allgemeinzustand) und gutem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Sie beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit gestern stechende, brennende, ziehende Lumbalgie, die in linkes Bein ausstrahlen. Die Schmerzen haben plötzlich begonnen nach einer Hebung eines Kübels im Garten und sind seitdem persistierend. 7 von 10 auf einer Schmerzskala. Verstänkernde Faktoren sind Aufstehen, Sitzen und sich nach vorne beugen. Lindernde Faktoren sind Liegen, Beinhochlagerung und Diclofenac. Sie beschreibt ähnliche Beschwerden seit einem Jahr aber leichter. Es gibt kein weitere neurologischen Symptome.

Begleitend ist Nausea nach der Einnahme von Diclofenac, und seit langer Zeit Kaltschweissigkeit.

Ansonsten ist die weitere vegetative Anamnese unauffällig.

Sie leidet seit ? J. an Migräne mit Aura und nimmt bei Bedarf dagegen Dolortriptan.

Von Beruf ist sie Floristin und tragt regelmäßig schwere Dinge.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf lumbaler Diskusprolaps / Muskelverspannung. An Differentialdiagnosen sind zu nennen, Spinalkanalstenose, Muskelverspannung, Lendenwirbelfrakturen (durch Osteoporose), Urolithiasis, Knochenmetastasen/Osteosarkome

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen (**Lasègue-Zeichen**); dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: kl. BB, Endzündungsparameter, E-lyte und Vitamin-D3-Profil, Urinstatus

Anschließend ist eine Röntgenaufnahme von Lendenbereich in 2 Ebenen und eine MRT durchzuführen. Auch eine Farbkodierte Dopplersonografie der Beingefäße. Ggf. CT-LWS.

Ich werde sie ambulant behandeln.

Zunächst wird eine konservative Therapie mit Analgetika, Muskelrelaxantien (**Methocarbamol**) und Physiotherapie empfohlen. Ggf. Einspritzung des Cortisols.
Eine operative Therapie, wie eine Nukleoplastie, wird vorschlagen, wenn es einem schweren Vorfalle gibt oder Red-Flag-Symptome auftreten wie z.B. Reithosenanästhesie, Harn- und Stuhlinkontinenz, Parese, Zustand nach Wirbelfraktur, bekannte Osteoporose oder Infektionen. Oder wenn es keine Besserung bei der konservativen Therapie.

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

Was ist Dolortriptan? = ein rezeptfreies Medikament, das den Wirkstoff Almotriptan enthält wirkt vasokonstriktiv auf die zerebralen Blutgefäße und unterdrückt so den durch die Vasodilatation bedingten Migräneschmerz.

Diskusprolaps = Bandscheibenvorfall
= Verlagerung der Bandscheibe (den Austritt des Nucleus pulposus von Gewebe). Dabei kann es zu einer Kompression des Rückenmarks oder der Nervenwurzeln kommen.

Etiopathogenese:

- Verschleißerscheinungen (Degeneration) mit Alterungsprozesse
- Übermäßige oder Fehlbelastung
- Verletzungen
- Übergewicht

Stadien:

- *Protrusion*: Breitbasige oder umschriebene Vorwölbung der Bandscheibe bei intaktem Anulus fibrosus
- *Prolaps* bzw. Bandscheibenvorfall: Vorwölbung von Nucleus pulposus durch Defekt im Anulus fibrosis
- Treten Einrisse des Anulus fibrosus auf, können Anteile des Nucleus pulposus austreten (Prolaps). Verliert der Prolaps Kontakt zur ursprünglichen Bandscheibe, spricht man von einem *Bandscheibensequester*.

Diagnostik:

- *Klinische Untersuchung*: neurologische Untersuchung ❑ Lähmung (Parese / Paralyse), Taubheitsgefühl (Hypästhesie), und Nervenreflex
  - **Lasègue-Zeichen** (= Dehnungsschmerz): der Patient liegt flach auf den Rücken, das gestreckte Bein wird im Hüftgelenk langsam passiv um 90° gebeugt. Das Zeichen ist positiv, wenn eine Beugung um 70-80° nicht durchführbar ist ❑ Rückenmarkssegmente L4-S2
  - **Bragard-Zeichen**: wird der Fuß passiv dorsalflektiert
- *MRT*: der prolabierte Bandscheibenanteil ist T1-isointens und T2 hyperintens

Differentialdiagnosen:

- Spinalkanalstenose = Einengung des Spinalkanals
- Facettensyndrom = degenerative Prozesse der kleinen Wirbelgelenke (Facetten) ❑ positive Druckschmerz und keine Parästhesien
- pAVK: es gibt Claudicatio intermittens, verminderte Fußsensibilität

Therapie:

- *konservative Therapie*
  - Analgetikum und Physiotherapie
- *Operative Verfahren*, in fällen, in denen Red-flag auftreten (Reithoseanästhesie, Harn- und Stuhlinkontinenz, Parese, Z.n. Wirbelfraktur, bekannte Osteoporose, Infektionen usw.)
  - Diskektomie / Nukleoplastie

Erinnerung an schwierige Entbindungen:

- Vakuumextraktion = Saugglockegeburt
- Forcepsextraktion = Zangengeburt
- Sectio caesarea = Kaiserschnitt

Bragard Zeichen → Das Bragard Zeichen ist positiv, wenn nach Absenken des gestreckten Beins und anschließender Dorsalflexion des Fußes erneut radikuläre Schmerzen auftreten, was für eine lumbale Nervenwurzelreizung spricht.

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

Patient/ in
Astrid Fischelmann
55 J. 11.04.1968
1,64 m 64,3 kg

Datum
05.01.2026

(nur Stichpunkte) aktuelle Beschwerden

- Rückenschmerzen im mittleren Lendenbereich, seit gestern bestehend
- plötzlich nach einer Hebung eines schweren Kübels aufgetreten,
- stechend, brennend, ziehend, persistierend
- 7/10 auf der Schmerzskala
- Ausstrahlung in linke Bein bis zur Ferse
- verschlimmernd beim Stehen, Sitzen, nach vorne Beugen
- lindernd beim Liegen, Hochbeinlagerung, nach Einnahme von Diclofenac 75 mg
- rezidivierend seit 1 Jahr (leichter)

Begleitsymptome
- Nausea nach Einnahme von Diclofenac

Vorerkrankungen
- ohne Parese
- ohne Parästhesie
- ohne Urin-Stuhlinkontinenz

- Migräne seit 10 Jahren
- Kopfschmerzen seit längerer Zeit (ohne Hausarztbesuch, 1-2 Mal jede 3 Monat)

Vegetativanamnese
- schmerzbedingte Dyssomnie
- Kaltschweiß

Gynäkologie anamnese
- Menopause seit 5 Jahren

OP
- 2.n. Sectio Caesarea vor 30 Jahren
- 2.n. Uterusexstirpation vor 28 Jahren

Kumulzustand

Medikamente
- Dolotriptan in unklarer Dosis b.B.
- Ibuprofen 400 mg b.B.
- Calcium Sandoz b.B. (zur Prevention von Knochenschwund Osteoporose)

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

Allergien / Unverträglichkeiten

Heuschnupfen (Rhinokonjunktivitis)

Genussmittel

Nikotin → 1 Zigarette pro 2–3 Woche

Alkohol → 2 Gläser Wein pro Woche

Drogen → unauffällig

Sozialanamnese

- Floristin (trägt schwere Sache)
- geschieden
- lebt allein
- 2 Söhne (gesund)

Familienanamnese

Vater → aHT

Mutter → DM Typ II

Schwester → an Bronchialkarzinom gestorben

Anamnesebogen - Ärztekammer Nordrhein – Fachsprachprüfung

(benutzen Sie Fachwörter, wo möglich) Verdachtsdiagnose

Lumbalgie

Differentialdiagnose

- Discusprolapsus
- Spinalkanalstenose
- Lendenwirbelfraktur

weiteres Procedere

- KU (Lasegue Zeichen)
- Vitalparameter
- Labor → kleine BB, Entzündungsparameter (CRP), D-Vitamine, Nieren-Leberwerte, Elektrolytwerte.
- Röntgen-Lumbal LWS in 2 Ebenen
- ggf. MRT-LWS

Therapie

- ambulante Behandlung
- Analgetika
- Muskelrelaxantien (Methocarbamol)
- Physiotherapie
- Patientenschulungen
- ggf. Konsil in Neurologie

Man unterscheidet bei Bandscheibenerkrankungen die Protrusion (Vorwölbung bei intaktem Anulus) und den Prolaps (Austritt von Bandscheibenmaterial bei rupturiertem Anulus) und den Sequester (abgelöstes freies Fragment im Spinalkanal). Mit zunehmendem Stadium steigt das Risiko für neurologische Defizite

Degenerative Bandscheibenerkrankung (Begleitprozess)
Höhenminderung, Dehydratation der Bandscheibe, Osteophyten → chronische Rückenschmerzen.

MRT T1- T2 Sequenz

T1 und T2 bezeichnen unterschiedliche MRT-Gewichtungen
T1 dient vor allem der anatomischen Darstellung, während T2 Flüssigkeit und Ödem darstellt. Ein T2-hypointenses Bandscheibenmaterial spricht für erhöhten Wassergehalt bzw. entzündliche Aktivität

T1 → Anatomie gut, gut gesehen
T2 → Ödem, Entzündungen gesehen

Spondylolisthese → Verschiebung der Wirbelkörper
Spondylose → degenerative Veränderungen der Wirbelkörper → Verschleiß der Wirbelsäule
Spondylitis → Osteomyelitis entzündlich
Discitis → Discitis entzündlich
(Querschnittsyndrom)
Konus-Kauda Syndrom (Conus oder Cauda-equina-Syndrom) L4-S3
Ominös ist der Conus medullaris vorne und der eine sind Sakralwurzeln (Cauda equina) bisweilen ungemein ist etwas neurologisch auf dem

Reithosenanästhesie
Harn und Stuhlinkontinenz
Parese der Beine
Lendenschmerzen mit Ausstrahlung ins Bein

Das Wurzelsyndrom

das Kernig Zeichen → Schmerzen bei Verdacht auf Meningitis
das Brudzinski Zeichen →

Dansch

✓ Lumbalgie → Schmerzen im unteren Rückenbereich, ✓ ohne Ausstrahlung ins Bein

✓ keine Neurologische Ausfälle

✓ Discusprolapsus → Vorwölbung oder Austritt von Bandscheibenmaterial mit möglicher Nervenkompression

kann neurologische Defizite verursachen (Sensibilitätsstörungen, Paresen)

✓ Lumboischialgie → Rückenschmerzen mit Ausstrahlung entlang des N. ischiadicus ins Bein.

häufig verursacht durch einen Discusprolaps

Nicht jeder Lumboischialgie ist ein Bandscheibenvorfall, und nicht jeder Bandscheibenvorfall verursacht eine Lumboischialgie

✓ Bei der Osteochondrose kommt es zu einem altersbedingten Verschleiß der Bandscheiben und Wirbelkörper

Skoliose → Scoliose → ist eine seitliche (egitme) Verbiegung der Wirbelsäule mit gleichzeitiger Rotation der Wirbelkörper

Bei der Scoliose ist die Wirbelsäule seitlich verbogen und verdreht.

X-Bein (Genu valgum)

Die Knie stehen zusammen, die Füße sind auseinander
Die Beine bilden eine X Form

O-Bein (Genu varum)

Die Füße stehen zusammen, die Knie sind auseinander.
Die Beine bilden eine O-Form

Kaltschweiß

Kaltschweiß ist kalter, feuchter Schweiß bei akuter Belastung oder Schock
z.B → Schock, MI, starke Schmerzen, Hypoglykämie
entsteht durch eine Akute Aktivierung des sympathikus bei Stress, Schmerz oder Schock

Schweißausbrüche

sind plötzliche, starke Schweißepisoden.
Panikattacke, Fieber, Menopaus, Hypoglykämie
entstehen durch plötzliche vegetative oder hormonelle Ak-

Nachtschweiß

Nachtschweiß ist starkes Schwitzen während der Nacht.
z.B – Infektionen, TBC, Infarkt, Menopaus, Krebs

entsteht durch eine veränderte Temperaturregulation im Hypothalamus bei Infektionen oder Erkrankung

Man unterscheidet bei Bandscheibenerkrankungen die Protrusion (Vorwölbung bei intaktem Anulus) und den Prolaps (Austritt von Bandscheibenmaterial bei rupturiertem Anulus) und den Sequester (abgelöstes freies Fragment im Spinalkanal). Mit zunehmendem Stadium steigt das Risiko für neurologische Defizite

Degenerative Bandscheibenerkrankung (Begleitprozess)
Höhenminderung, Dehydratation der Bandscheibe, Osteophyten → chronische Rückenschmerzen.

MRT T1- T2 Sequenz

T1 und T2 bezeichnen unterschiedliche MRT-Gewichtungen
T1 dient vor allem der anatomischen Darstellung, während T2 Flüssigkeit und Ödem darstellt. Ein T2-hypointenses Bandscheibenmaterial spricht für erhöhten Wassergehalt bzw. entzündliche Aktivität

T1 → Anatomie → gut, gut gestern

T2 → Ödem, Inflammation gestern

Spondylolisthese → Verschiebung der Wirbelkörper → Verschieben der Wirbelkörper
Spondylose → degenerative Veränderungen der Wirbelkörper
Spondylitis → Osteomyelitis entzündlich
Discitis → Discitis entzündlich

Konus-Kauda Syndrom (Querschnittsyndrom) (Conus oder Cauda-equina-Syndrom) LL-S3
Ohne Beteiligung aller Wurzeln (Conus medullaris) vorne oder einen sind Sakralwurzeln (Cauda equina) bisweilen vorhanden einzelne neurologische Ausfälle

Reithosenanästhesie
Harn und Stuhlinkontinenz
Parese der Beine
Lendenschmerzen mit Ausstrahlung ins Bein

Das Wurzelsyndrom

Das Kernig Zeichen → Knie kann nicht gestreckt werden bei Verdacht auf Meningitis
Das Brudzinski Zeichen →

Danach

✓ Lumbalgie → Schmerzen im unteren Rückenbereich, ✓ ohne Ausstrahlung ins Bein

✓ keine Neurologische Ausfälle

✓ Discusprolapsus → Vorwölbung oder Austritt von Bandscheibenmaterial mit möglicher Nervenkompression

kann neurologische Defizite verursachen (Sensibilitätsstörungen, Paresen)

✓ Lumboischialgie → Rückenschmerzen mit Ausstrahlung entlang des N. ischiadicus ins Bein.

häufig verursacht durch einen Discusprolaps

Nicht jeder Lumboischialgie ist ein Bandscheibenvorfall, und nicht jeder Bandscheibenvorfall verursacht eine Lumboischialgie

✓ Bei der Osteochondrose kommt es zu einem altersbedingten Verschließ der Bandscheiben und Wirbelkörper

Skoliose → Scoliose → ist eine seitliche (eigene) Verkrümmung der Wirbelsäule mit gleichzeitiger Rotation der Wirbelkörper

Bei der Scoliose ist die Wirbelsäule seitlich verkrümmt und verdreht.

X-Bein (Genu valgum)

Die Knie stehen zusammen, die Füße sind auseinander
Die Beine bilden eine X Form

O-Bein (Genu varum)

Die Füße stehen zusammen, die Knie sind auseinander.
Die Beine bilden eine O-Form

Kaltschweiß

Kaltschweiß ist kalter, feuchter Schweiß bei akuter Belastung oder Schreck
z.B. → Schrecken, Angst, starke Schmerzen, Hypoglykämie
entsteht durch eine akute Aktivierung des sympathikus bei Stress, Schmerz oder Schreck

Schweißausbrüche

sind plötzliche, starke Schwitzepisoden.
Panikattacken, Fieber, Menopause, Hypoglykämie
entstehen durch plötzliche vegetative oder hormonelle Ab-

Nachtschweiß

Nachtschweiß ist starkes Schwitzen während der Nacht.
z.B. → Infektionen, TBC, Infarkt, Menopause, Krebs

entsteht durch eine veränderte Temperaturregulation im Hypothalamus bei Infektionen oder Unterkühlung